Número do processo: 0732008-43.2025.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MARIANA DE SOUZA MENDES

REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

SENTENÇA

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de pedido de tutela de urgência, proposta por MARIANA DE SOUZA MENDES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, partes qualificadas.

A autora relata que é beneficiária do plano de saúde operado pela ré.

Aduz que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID10: G35d), tendo sido indicado por seu médico assistente o uso do medicamento *CLADRIBINA 10mg/ (MAVENCLAD)*, para fins de consecução do seu tratamento.

Narra que a ré recusou o seu fornecimento, sob o argumento de possuir caráter domiciliar.

Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento declinado na peça de ingresso. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória.

Com a inicial foram juntados documentos nos IDs 239982589 a 239993499. Guia de custas e comprovante de recolhimento no ID 239993499.

A decisão de ID 240002003 deferiu o pedido de tutela de urgência.

A ré interpôs agravo de instrumento dessa decisão, ao qual fora negada a concessão de efeito suspensivo por este E. TJDFT (ID 243164027).

Citada, a ré apresentou contestação no ID 242302596 e documentos nos IDs 242302597 a 242302600.

Defende a ré que: a) há incorreção no valor atribuído à causa; b) o rol de procedimentos da ANS é taxativo; c) o medicamento possui caráter domiciliar, sem cobertura contratual. Requer, ao final, o julgamento de improcedência dos pedidos.

Réplica no ID 243607398.

A decisão de ID 244595853 determinou o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC, porquanto a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos.

Verifico presentes os pressupostos processuais e sigo ao exame do mérito.

Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo.

Isso porque a demandada é prestadora de serviços de saúde, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e a parte requerente é consumidora, pois destinatária final do serviço adquirido (artigo 2º do CDC).

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado 608 da Súmula do col. Superior Tribunal de Justiça: *aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*.

Estando diante de uma relação de consumo, a pretensão da autora há de ser amparada pelo sistema de defesa do consumidor, pois sujeito vulnerável informacional, técnica, jurídica e faticamente, sem se olvidar do emprego subsidiário do CPC, e de outras normas contidas no ordenamento que regem a matéria.

A recusa ou a demora injustificada à prestação de cobertura contratada é conduta ilícita e enquadra-se no conceito de defeito no serviço, acarretando a responsabilidade objetiva da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC:

> *O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.*

Consignadas essas premissas, verifico que a relação estabelecida entre as partes está comprovada pela carteirinha do plano de saúde de ID 239982594.

A indicação para o tratamento objeto da lide extrai-se dos relatórios médicos de IDs 239985159 e 239985161, e a negativa da ré do documento de ID 239985167.

O col. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter taxativo, nos seguintes termos:

> *i) O rol é, em regra, taxativo;*
>
> *ii) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;*
>
> *iii) É possível a contratação de cobertura ampliada, ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento que não esteja incluído no rol;*

> *iv) Não havendo substituto terapêutico, ou esgotado os procedimentos do rol, pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente desde que: i) não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como Conitec e Natjus e estrangeiros e iv) seja realizado, quando possível, o dialogo interinstitucional dos magistrados com entes e pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de comissão de atualização do rol, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a justiça federal, ante a ilegitimidade passiva ad causum da ANS.* (Embargos de divergência em Resp n. 1886929/SP – 2020/0191677-6)

Por outro lado, o Congresso Nacional, em inegável reação legislativa (efeito *backlash*), superou o mencionado entendimento, para compreender o rol da ANS como uma referência básica, vale dizer, revestido de caráter exemplificativo, na forma do artigo 10, §13, da Lei 9.656/98:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)*

Basta para o paciente, nessa esteira, comprovar, alternativamente, que o tratamento: a) possui eficácia comprovada cientificamente; b) seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou c) seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.

Tal avanço legislativo sobre a temática socorre a autora no caso em apreço.

Com base na recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC e após a consulta pública, o Ministério da Saúde incorporou a *Cladribina* oral à lista de medicamentos do SUS.

Essa decisão foi oficializada pela Portaria SECTICS/MS 62, de 27 de outubro de 2023.

Daí se observa, por si só, a eficácia do tratamento pretendido, em consonância com o novel entendimento sobre a matéria.

A ré, por sua vez, recusou o fornecimento do medicamento, em razão do seu caráter domiciliar.

Com efeito, a exclusão de cobertura para o fornecimento de medicamento domiciliar está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, o qual condiciona a cobertura de medicamentos para tratamento de uso ambulatorial/domiciliar à expressa previsão contratual, ressalvadas as exceções legais, referentes aos antineoplásicos de uso domiciliar e os antineoplásicos domiciliares que representem continuidade do tratamento hospitalar.

O medicamento de uso domiciliar não necessita de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência).

Na espécie, embora o medicamento postulado seja efetivamente de uso domiciliar, a obstar, em tese, o seu fornecimento pela ré, o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam entendimento diverso.

A uma, porque há expressa orientação da CONITEC nesse sentido, mormente ao se considerar que há contraindicação para aplicação do medicamento *NATALIZUMABE* à autora, conforme esclarecido por seu médico assistente (ID 239985161, p. 2):

> *Além disso, paciente apresenta quadro de pavor a agulha com* ***intolerância a medicações injetáveis****. Importante frisar ainda que paciente é JC positivo com altos títulos o que* ***aumenta consideravelmente o risco de LEMP com uso de natalizumabe****, sendo essa uma infecção grave com alta morbidade e mortalidade, reiterando a indicação do Mavenclad como excelente opção terapêutica.* (Grifou-se)

A duas, porque o não fornecimento do medicamento implicaria o agravamento do seu quadro, com inevitáveis internações subsequentes, das quais resultariam maior ônus financeiro ao plano réu, se comparado ao proveito econômico desta lide. Cito, por oportuno, o seguinte trecho do relatório médico de ID 239985161, p. 2:

> *Disso, o paciente tem indicações precisas de iniciar tratamento de alta eficácia, a fim de evitar possíveis surtos graves e incapacitantes, além de prevenir evolução para fase progressiva e degenerativa.*

Assim, não é razoável exigir que a autora *passe, de plano, para a etapa subsequente de tratamento, na contramão das recomendações dos órgãos técnicos e da médica assistente, e que seja submetida a tratamento injetável, realizado em ambiente hospitalar, quando pode fazer uso de tratamento via oral, mais prático, indolor e sem gastos com deslocamento e dispêndio de tempo, além de representar custo inferior para a operadora do plano de saúde, não afetando o equilíbrio contratual* (AgInt no AREsp n. 2.251.773/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/9/2024.)

Confira-se, a respeito, o seguinte aresto, prolatado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, em hipótese congênere a dos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. USO DOMICILIAR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. A pretensão recursal visava à reforma do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do TJDFT, que ***confirmou a condenação da operadora ao fornecimento do medicamento Mavenclad para tratamento de esclerose múltipla em regime domiciliar, mesmo não incluído no rol da ANS****. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 83 do STJ, ao concluir que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência dominante do Tribunal; (ii) verificar se a parte agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por reconhecer que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, inclusive para uso domiciliar e fora do rol da ANS, quando presentes os critérios de excepcionalidade (Súmula 83/STJ).

4. A pretensão recursal também depende da revaloração do conjunto fático-probatório e da análise da adequação do tratamento médico, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. A agravante não impugnou especificamente tais fundamentos, limitando-se à repetição das teses já enfrentadas pela decisão agravada, o que caracteriza deficiência de dialeticidade e atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.

6. A jurisprudência da Corte tem reiteradamente reconhecido a aplicação da Súmula 83 quando o acórdão recorrido reflete entendimento pacificado sobre o fornecimento de medicamentos fora do rol da ANS, sobretudo em casos de esclerose múltipla e medicamento como Mavenclad. *IV. DISPOSITIVO*

7. Agravo não provido. (AREsp n. 2.667.222/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.) (Grifou-se)

Em igual sentido, é o entendimento perfilhado por este E. TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. TRATAMENTO COM MAVENCLAD (CLADRIBRINA). USO DOMICILIAR. EXCEÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).

2. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.

> *3. Decretada a nulidade parcial da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/15.*
>
> *4. Cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento da Autora, para a qual foi prescrito o uso do fármaco Mavenclad 10mg (Cladribina) em virtude do diagnóstico de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, considerando-se a previsão contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.*
>
> ***5. Diante da gravidade e das particularidades da enfermidade em questão, tal dispositivo legal não pode ser utilizado como óbice ao fornecimento da medicação pleiteada. Precedentes do TJDFT e do STJ.***
>
> *6. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar acolhida.*
>
> *(Acórdão 2020868, 0741928-75.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.)* (Grifou-se)

Deste modo, não se trata de negar vigência ao disposto no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, mas de interpretá-lo conforme o caso concreto, levando em considerações as particularidades do quadro clínico da paciente, bem como a análise econômica do direito.

Sob qualquer prisma, portanto, tem-se obrigatório o custeio do medicamento objeto da lide pela ré, a qual, em última análise, suportará ônus financeiro inferior ao da negativa apresentada.

DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR à ré que forneça e custeie o medicamento *MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina),* por 2 (dois) ciclos anuais (10 comprimidos cada ciclo), totalizando 20 (vinte) comprimidos em um ano, conforme prescrição médica ID 239985164, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação da decisão de ID 240002003, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação de fazer, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.

**** Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.***

Assinado eletronicamente por: THAIS ARAUJO CORREIA
01/08/2025 14:19:02
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:
25080114190189700000222

IMPRIMIR GERAR PDF